

抗胆碱能药物（用于膀胱过度活动症）

WARWIKI

患者须知 · 抑制膀胱过早收缩的药物

抗胆碱能药物（又称抗毒蕈碱药）可平息膀胱过度活动症（OAB），减少突发尿急、频繁如厕及急迫性尿失禁。常用药物包括 **oxybutynin**（奥昔布宁）、**tolterodine**（托特罗定）、**solifenacin**（索利那新）、**fesoterodine**（非索罗定）、**darifenacin**（达非那新）和 **trospium**（曲司氯铵）（oxybutynin 亦有贴片和凝胶剂型）。这类药物使用历史悠久，疗效确切。

作用原理

这类药物通过**阻断信号**来抑制膀胱肌肉收缩，使其在充盈过程中不那么频繁、不那么突然地收缩，从而减轻尿急感和如厕次数。用药期间可缓解症状；疗效通常需数周后逐渐显现。

预期效果

- 改善通常在**数周内**出现 — 请勿过早判断疗效。
- 多数缓释剂型**每日服用一次**。
- **缓释片、贴片或凝胶**比速释型 oxybutynin 口干副作用更少。

名词解释

膀胱过度活动症（OAB）

膀胱过早收缩引起的尿急和尿频。

抗胆碱能药／抗毒蕈碱药

一类平息膀胱肌肉的药物。

口干

最常见的副作用。

抗胆碱能负荷

同时使用多种此类药物的叠加效应 — 在老年人中尤需关注。

β 3 受体激动剂

另一类 OAB 药物，此类副作用较少（可作为替代）。

闭角型青光眼

一种眼部疾病，通常须避免使用这类药物。

老年人特别提示 在老年人中，这类药物可能影响**记忆力和思维能力**，长期联合使用多种抗胆碱能药物与认知风险存在关联。如有顾虑，**β3 受体激动剂**是不具有此类影响的 OAB 替代药物 — 请咨询您的医疗团队。

服用方法

- 按医嘱**每日一次**服用；不要因尿急尚未完全改善就自行停药。
- 若口干困扰明显，可询问是否改用**缓释剂型、贴片或凝胶**。
- 配合膀胱训练和盆底肌锻炼效果更佳。

重要安全须知

- 未经治疗的**闭角型青光眼**患者通常须避免使用 — 请告知医疗团队您的眼部情况。
- 若有**排尿困难**、严重便秘或某些胃肠道疾病，请谨慎使用。
- 此类药物可减少排汗 — **高温天气**时注意防止过热。

副作用

- **口干和便秘**（最常见）
- 视力模糊、眼睛干涩
- 嗜睡；老年人可能出现意识混乱

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **无法排尿**或感觉膀胱排空不完全
- **出现新的意识混乱或记忆问题**，尤其是老年人
- **严重便秘，或眼痛、眼红伴视力模糊**

需要记住的三件事

1. 抗胆碱能药物可平息膀胱过度活动症，缓解尿急、尿频和急迫性尿失禁；请给予数周时间观察疗效。
2. 口干和便秘较常见 — 缓释剂型、贴片或凝胶有助于减轻这些不适。
3. 老年人用药可能影响认知功能；β3 受体激动剂可作为替代选择。如出现无法排尿或新发意识混乱，请及时联系医疗团队。